

CE QUE PERSONNE NE VOUS EXPLIQUE

Vous n'êtes pas censé savoir... mais vous n'êtes pas obligé de subir.

Guide 1 — Série Culture du soin

Sommaire

1. Ce que personne ne vous explique

Comprendre le fonctionnement réel d'un EHPAD et les décalages que vous pouvez ressentir.

2. Qui décide vraiment

Faire le point sur les rôles de chacun pour y voir plus clair.

3. Pourquoi vous avez l'impression de perdre votre place

Mettre des mots sur un ressenti fréquent... et légitime.

4. Comment reprendre sa place sans conflit

Des repères concrets pour être entendu et retrouver une place active.

5. Quand quelque chose ne va pas

Savoir réagir face à une situation inquiétante sans rester seul.

6. Les erreurs à éviter

Éviter ce qui complique souvent les choses... sans le vouloir.

7. Ce qui peut tout changer

Les leviers simples qui, dans le temps, font réellement la différence.

Introduction

Quand un proche entre en EHPAD, on pense souvent que le plus dur est fait.

En réalité... c'est là que tout commence.

Les règles changent. Les repères disparaissent. Et beaucoup de familles se retrouvent à naviguer à l'aveugle.

Ce guide est là pour ça. Pour vous aider à comprendre... et surtout à retrouver votre place.

Une chose avant de commencer

Je travaille depuis des années auprès de personnes âgées en établissement. J'ai vu des familles arriver confiantes, et repartir perdues. J'en ai vu d'autres, épuisées, qui ne savaient plus si elles avaient le droit de poser des questions.

Ce que j'ai compris, c'est que leur souffrance n'était presque jamais causée par la mauvaise volonté des équipes. Elle venait du silence. Du manque d'explication. De personne ne prenant le temps de dire : voilà comment ça fonctionne vraiment.

Ce guide, c'est ce temps-là. Celui que le système ne prend pas.

1. Ce que personne ne vous explique

Quand votre proche entre en EHPAD, on vous parle souvent de sécurité, de prise en charge, d'équipe, d'accompagnement. Sur le papier, tout semble clair.

Mais ce que vous découvrez ensuite... est souvent très différent.

Un EHPAD, ce n'est pas un domicile. C'est un lieu de vie... mais aussi une organisation. Avec des horaires. Des contraintes. Des priorités. Et surtout : du collectif.

Votre proche devient une personne parmi d'autres. Même s'il reste unique pour vous, le fonctionnement ne peut pas toujours s'adapter entièrement à lui.

C'est là que naît souvent un décalage. Vous voyez des choses qui vous semblent évidentes :

- une télé allumée qui ne l'intéresse pas
- peu de stimulation
- des habitudes qui ne sont pas respectées
- une impression qu'il "s'efface"

Et vous vous dites : "Mais ils ne voient pas ?"

En réalité, ce n'est pas aussi simple. Les équipes savent beaucoup de choses. Mais dans le quotidien, avec le rythme, la fatigue, la charge de travail... tout ne peut pas être ajusté comme on le souhaiterait.

Alors certaines informations restent en arrière-plan. Pas par manque d'humanité. Mais parce que le système impose un cadre... et que ce cadre prend parfois le dessus.

C'est dur à entendre. Mais c'est important de le comprendre. Parce que ce décalage que vous ressentez... il est réel. Et vous n'êtes pas le seul à le vivre.

Comprendre le fonctionnement, ce n'est pas accepter... c'est pouvoir agir au bon endroit.

2. Qui décide vraiment ?

Quand un proche entre en EHPAD, une question revient très vite : “Mais au final... qui décide ?” Et souvent, la réponse semble floue.

On a l'impression que tout se décide “ailleurs”. Que tout est déjà en place. Et que la famille n’a plus vraiment son mot à dire. La réalité est plus nuancée. Mais elle est rarement expliquée clairement.

Le médecin

C’est lui qui décide des traitements, des prescriptions, des orientations médicales. Il a une responsabilité importante. Mais il ne voit pas toujours le résident au quotidien.

L’équipe soignante

Elle applique les soins, observe, adapte, alerte. C’est elle qui connaît le mieux le quotidien de votre proche. Mais elle travaille dans un cadre précis, avec des contraintes.

La direction

Elle organise, encadre, structure. Elle pose les règles de fonctionnement.

Le tuteur (s’il y en a un)

Il prend certaines décisions administratives ou financières. Parfois aussi des décisions importantes, selon le niveau de protection.

Et vous, la famille ?

C’est là que ça se complique. Vous n’avez pas “tous les pouvoirs”. Mais vous n’êtes pas non plus à l’écart. Vous avez un rôle. Une légitimité. Une connaissance unique de votre proche. Mais ce rôle n’est pas toujours clairement défini. Et c’est là que naissent les tensions.

Parce que chacun pense être dans son bon droit :

- la famille veut comprendre, participer

- l'équipe veut protéger, organiser
- le médecin tranche parfois sans expliquer

Et au milieu... vous pouvez avoir l'impression de subir.

La vérité : personne ne décide seul. Mais sans communication claire, ça peut donner l'impression que vous ne décidez plus rien.

Ce qu'il faut retenir : vous avez le droit de poser des questions, de comprendre, d'être associé. Mais encore faut-il savoir comment.

Comprendre qui fait quoi... c'est déjà reprendre une partie de sa place.

3. Pourquoi vous avez l'impression de perdre votre place

C'est souvent ce que les familles décrivent le plus. Sans toujours oser le dire clairement.

- “J'ai l'impression de ne plus servir à rien...”
- “Je ne sais plus quelle est ma place...”
- “Tout se fait sans moi...”

Ce ressenti est réel. Et surtout... il est fréquent.

Avant l'entrée en EHPAD, vous étiez au cœur. Vous connaissiez chaque habitude, chaque réaction, chaque détail. Vous aidiez. Vous décidiez. Vous étiez présent, tout simplement.

Puis, en entrant en EHPAD... tout change. Les soins sont pris en charge. Les décisions sont encadrées. Le quotidien est organisé autrement. Et petit à petit... vous êtes mis en retrait. Pas forcément volontairement. Mais par le fonctionnement même de l'institution.

Alors vous vous adaptez. Vous observez. Vous hésitez. Parfois, vous n'osez plus poser des questions, proposer quelque chose, dire que “ça ne va pas”. De peur de déranger. De mal faire. Ou d'être mal perçu.

Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas “dans votre tête”. C'est une conséquence directe du système. Vous avez changé de rôle... sans qu'on vous explique comment le retrouver autrement.

Vous n'avez pas perdu votre place. Vous ne savez simplement pas encore comment l'occuper autrement.

4. Comment reprendre sa place (sans conflit)

Reprendre sa place ne veut pas dire s'opposer. Ni se battre. Ni contrôler. Ça veut dire : redevenir présent, utile... et entendu. Et ça commence souvent par des choses simples. Mais essentielles.

1. Poser des questions (et oser les poser)

Vous avez le droit de comprendre un changement de traitement, une chute, un comportement inhabituel. Ne restez pas avec des doutes. Parfois, il ne s'agit pas d'un problème grave... mais juste d'un manque d'explication.

2. Dire ce que vous savez (même si ça paraît évident)

“Il est malentendant”, “Elle n'aime pas la télé”, “Il a toujours eu besoin de sortir”... Ce qui est évident pour vous ne l'est pas toujours dans le quotidien. Et surtout : il faut parfois le redire. Pas parce que l'équipe ne sait pas... mais parce que ces informations se perdent dans le rythme.

3. Choisir comment dire

La forme change tout. Préférer “Je me demandais si...” ou “Est-ce que c'est possible de...” plutôt que “Vous devriez...” ou “Ce n'est pas normal...”. Parce que l'objectif n'est pas d'avoir raison. C'est d'être entendu.

4. Créer un lien, pas un rapport de force

Les équipes sont souvent sous pression. Quand le lien est simple, humain, respectueux... tout devient plus fluide. Un échange, un mot, une reconnaissance... ça peut tout changer.

5. Être présent... mais justement

Être présent ne veut pas dire être partout. C'est choisir les bons moments, les bons sujets, les bons mots. Et accepter que tout ne soit pas parfait... tout en restant attentif à l'essentiel.

6. Accompagner, pas remplacer

Votre rôle n'est pas de faire à la place. Mais de compléter : transmettre, ajuster, rappeler, humaniser. Et ça... personne ne peut le faire à votre place.

Reprendre sa place, ce n'est pas prendre le contrôle... c'est redevenir acteur.

5. Quand quelque chose ne va pas

C'est souvent là que tout bascule. Une chute. Un hématome. Un changement brutal. Et une question qui revient immédiatement : “Qu'est-ce qu'il s'est passé ?”

Quand vous n'avez pas de réponse claire... l'inquiétude monte. Et parfois, le silence ou des réponses floues rendent la situation encore plus difficile.

Ce qu'il faut savoir

Les personnes âgées sont fragiles. Un simple mouvement, un déséquilibre, un choc léger... peuvent avoir des conséquences importantes. Parfois, l'événement n'est pas vu. Parfois, il est difficile à expliquer. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire.

La réalité (que l'on dit peu)

Il arrive aussi que les équipes ne sachent pas exactement ce qui s'est passé. Et dans ces moments-là : il peut y avoir de la gêne, de la peur, le sentiment de ne pas avoir assuré. Et parfois... le silence s'installe.

Ce que vous pouvez faire

Vous avez le droit de demander : “Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ?”, “Depuis quand c'est apparu ?”, “Qu'est-ce qui a été mis en place ?” Et si la réponse est “On ne sait pas exactement” — c'est inconfortable. Mais c'est une réponse honnête.

Ce qui doit vous alerter

- des explications contradictoires
- un refus de répondre
- un sentiment qu'on évite vos questions

Dans ces cas-là : ne restez pas seul, notez, reformulez, demandez à nouveau.

Le silence inquiète toujours plus que la vérité.

6. Les erreurs à éviter

Dans ces situations, on fait tous comme on peut. Avec l'émotion. Avec la fatigue. Avec l'inquiétude. Mais certaines réactions, même compréhensibles... peuvent compliquer encore plus les choses.

1. Se taire trop longtemps

Attendre, observer, espérer que ça s'améliore... Parfois on n'ose pas. Et quand on parle enfin... la situation est déjà installée.

2. Tout garder pour soi

Les doutes, les inquiétudes, les questions... Ce que vous ressentez est légitime. Et si vous ne le dites pas... personne ne peut l'ajuster.

3. S'énerver trop vite

Quand quelque chose ne va pas, la colère monte vite. Et c'est normal. Mais en face, cela peut fermer le dialogue. Le fond est souvent juste. La forme bloque.

4. Vouloir tout contrôler

Tout surveiller. Tout vérifier. Tout corriger. C'est épuisant. Et souvent inefficace. Votre rôle n'est pas de remplacer l'équipe.

5. Penser que “ça ne changera pas”

“C'est comme ça...”, “On ne peut rien faire...” C'est une pensée fréquente. Mais elle vous enferme. Dans beaucoup de situations, des ajustements sont possibles.

6. Attendre qu'on vous donne une place

C'est rarement spontané. Si vous ne la prenez pas un minimum... personne ne va venir vous la redonner.

Se taire protège sur le moment... mais isole sur la durée.

7. Ce qui peut tout changer

La communication

Pas parfaite. Pas toujours fluide. Mais présente. Poser des questions, reformuler, revenir vers l'équipe... encore et encore. Parce que c'est dans la répétition que les choses s'ancrent.

L'histoire de vie

Votre proche n'est pas qu'un résident. Il a une histoire, des habitudes, des peurs, des repères. Et vous êtes souvent la seule personne à pouvoir les transmettre vraiment. Même si cela a déjà été dit. Même si cela a déjà été écrit. Le redire change tout.

Les petits détails

Ce sont eux qui font la différence. Une habitude respectée. Un mot juste. Un moment partagé. Ce ne sont pas des "détails". Ce sont des repères.

La présence intelligente

Être présent ne veut pas dire être partout. C'est observer, ajuster, intervenir au bon moment. Sans s'épuiser. Sans s'effacer non plus.

La relation

Ce n'est pas toujours simple. Mais quand une relation de confiance s'installe, même fragile... tout devient plus fluide.

Et surtout... ne pas rester seul. Parler. Partager. Demander. Parce que ce que vous vivez... beaucoup d'autres le vivent aussi.

Vous avez encore une place.

Et elle peut faire toute la différence.

—

Ce guide est le premier d'une série. Parce qu'accompagner un proche en EHPAD, c'est traverser plusieurs étapes — et chacune mérite d'être comprise.

- **Guide 2 — La culpabilité :** survivre à la mise en institution.
- **Guide 3 — Alzheimer & démences :** comprendre pour rester en lien.
- **Guide 4 — La fin de vie :** accompagner sans fuir.

—

Et si vous avez besoin d'aller plus loin — d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre situation précise — je suis là.

www.capgrandage.fr

— *Culture du soin*